

ENURESIS

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Nefrología SAP 2008 – PRONAP 2018 Módulo 2

Generalidades

La mayor parte de los niños no controlan sus esfínteres hasta los 2 a 4 años de edad. Controlan primero durante el día y luego de noche.

El control completo de su vejiga es variable.

El término enuresis se utiliza habitualmente referido a las micciones involuntarias que se producen durante el sueño (enuresis nocturna).

Se reserva el término incontinencia urinaria para los episodios de enuresis que se producen durante la vigilia, y que, generalmente, implican micciones anormales, se acompañan de otros síntomas miccionales y, con frecuencia, son debidos a patología orgánica.

Definición

Enuresis nocturna:

“Emisión repetida de orina en la cama, con una frecuencia de dos episodios semanales, durante por lo menos 3 meses consecutivos, en niños de, al menos 5 años de edad, y no debida al efecto directo de una sustancia, ni a una enfermedad médica”. Este límite de edad pueda ser elevado en los varones hasta los 6 años, teniendo en cuenta que su maduración vesical tiene lugar más tardíamente.

Incontinencia:

Incapacidad de estar seco entre 2 micciones.

Es un síntoma de distintas causas como alteraciones anatómicas y funcionales de la vía urinaria.

Enuresis nocturna primaria: el niño NUNCA ha sido continente. Nunca ha habido por lo menos 6 meses consecutivos de cama seca.

Enuresis nocturna secundaria: luego de 6 meses consecutivos de amanecer con la cama seca (generalmente mucho más tiempo) el paciente comienza a mojar la cama de noche.

Incidencia

Se presenta con una frecuencia 1,5 a 2 veces mayor en los varones.

Afecta al 10-13% de los niños de 6 años y al 6-8% de los de 10 años.

Persiste en un 1% de los casos en la edad adulta.

Tasa de remisión anual del 15%.

Incidencia familiar alta, un 44% tienen un padre que fue enurético en la niñez, si ambos padres lo fueron el niño tiene hasta un 77% de probabilidades de tener enuresis.

Diagnostico

Anamnesis

a. Presencia de patología orgánica:

- ☐ Infección urinaria
- ☐ Malformaciones nefrourológicas
- ☐ Insuficiencia renal
- ☐ Hipercalciuria
- ☐ Diabetes insípida central y nefrogénica
- ☐ Diabetes mellitus
- ☐ Afecciones del sistema nervioso central
- ☐ Problemas neurológicos lumbo-sacros
- ☐ Epilepsia

b. Volumen de orina emitida en las micciones

c. Características del chorro miccional.

d. Capacidad de retención y presencia de retención urinaria diurna.

e. Existencia de disuria, polaquiuria o urgencia miccional.

f. Presencia de estreñimiento o encopresis.

- g. Historia de cefaleas, convulsiones o ausencias.
- h. Clínica litiásica previa

Anamnesis

- ☐ Primaria o secundaria
- ☐ Constante o en episodios irregulares
- ☐ Frecuencia de noches con episodios de enuresis
- ☐ Hora a la que se producen episodios enureticos
- ☐ Antecedentes filiales de enuresis
- ☐ Conflictos familiares
- ☐ Nacimiento de un hermano o fallecimiento de un familiar.
- ☐ Cambio de domicilio o de colegio
- ☐ Hospitalización
- ☐ Influencia del frío, vacaciones escolares u otras influencias externas.
- ☐ Tentativas terapéuticas previas
- ☐ Utilización de premios o castigos

Examen físico

- ☐ Peso y talla. Un retraso en la talla acompaña con frecuencia a la insuficiencia renal crónica y a otros trastornos nefrourológicos que cursan con poliuria.
- ☐ Presión sanguínea: Numerosas nefropatías y uropatías se acompañan de hipertensión arterial.
- ☐ Genitales y región lumbosacra: alteraciones en esas regiones pueden acompañarse de malformaciones urológicas.
- ☐ Abdomen: Un globo vesical puede indicar obstrucción. La palpación de fecalomas puede indicar la presencia de estreñimiento y/o encopresis.
- ☐ Fosas renales: Pueden ser dolorosas en las pielonefritis y en las hidronefrosis a tensión.
- ☐ Evaluación del sistema nervioso

Cartilla miccional de 24 hs.

Frecuencia miccional diaria (3 a 6 u 8 episodios diarios según autores).

Volumen de cada micción (Capacidad fisiológica funcional adecuada: Edad en años x 30 + 30= ml).

Exámenes complementarios

- Orina completa (en los pacientes con poliuria nocturna la densidad urinaria es frecuentemente baja) y urocultivo.
- Ecografía renal: evaluando capacidad vesical máxima, el espesor vesical en mm a capacidad máxima y el residuo post micción (espesor vesical superior a 2 mm y el residuo posmiccional superior al 20% de la capacidad vesical fisiológica por edad indica que podría existir una obstrucción urinaria inferior).
- El estudio urodinámico en niños sin clínica diurna no estaría indicado inicialmente. Sin embargo, debe realizarse cuando fracasa el tratamiento con desmopresina y alarmas de enuresis o cuando exista una sólida sospecha clínica de vejiga inestable.

Tratamiento

No farmacológico

- No castigar ni reprender al niño
- Sistemas de recompensa como gráficos de estrellas para las noches secas.
- Levantar y despertar a los niños durante la noche para que orine.
- Entrenamiento para el control de la retención para aumentar la capacidad de la vejiga (entrenamiento de la vejiga)
- Restricción de líquidos
- Alarmas de enuresis: es eficaz en el 60-70% de los casos, con una tasa de recaída del 5- 30%, que puede reducirse si se indica el consumo de grandes cantidades de

líquido durante la tarde para provocar enuresis después del éxito inicial o se acompaña de entrenamiento de cama seca.

Otras intervenciones no farmacológicas

- Tratamiento de la encopresis y/o del estreñimiento ha mostrado su eficacia para la corrección de la enuresis dada la asociación entre estreñimiento e hiperactividad del detrusor.
- La ortodoncia y la cirugía correctora de la obstrucción de vías respiratorias altas pueden ser curativas en los niños enuréticos que roncan.
- Se ha publicado también en alguna ocasión que son útiles, para tratar la enuresis la acupuntura, la hipnosis y las dietas hipoalergénicas.

Farmacológico

Desmopresina

Análogo sintético de la vasopresina sin efecto vasoconstrictor y vida media corta.

Reduce el volumen de orina durante la noche.

Eficacia del 40-80%, pero con una tasa de recaídas alta que puede disminuirse con una retirada gradual.

Dosis: 120 mcg a 240 mcg sublingual , 20-40 mg por vía intranasal, o 0,2-0,4 mg por vía oral.

Posología: dosis única al acostarse.

Duración del tratamiento: 3-6 meses inicialmente.

Sin efectos secundarios graves, salvo intoxicación hídrica si se acompaña de ingesta excesiva de líquidos.

Administrar correctamente, la subdosificación farmacológica, incorrectos horarios e incorrectos tiempos de administración resultará en resistencias farmacológicas.

Oxibutinina

Anticolinérgico y relajante muscular.

Actúa disminuyendo la hiperactividad del detrusor y aumentando la capacidad vesical.

Ha mostrado eficacia en, aproximadamente, la mitad de los enuréticos resistentes a las alarmas y a la desmopresina.

Dosis: 10-20 mg/día.

Posología: cada 12 ó 24 horas.

Duración del tratamiento: 3-6 meses inicialmente.

Efectos secundarios: sequedad de boca, vértigo y estreñimiento. La acumulación residual de orina que puede provocar aumenta el riesgo de infección urinaria.

Es previsible que un nuevo fármaco, la tolterodina, con igual eficacia, pero menos efectos secundarios. sustituya progresivamente a la oxibutinina.

Algoritmo

